



MISSIONS DES AMBULANCIERS

Référentiel DEA 2022/2024 vs. Pratique réelle

CHU de Toulouse · Établissements psychiatriques · SMUR

Document CGT / SUD · Mise à jour 27 juin 2026 · Intégration périmètre SMUR (AFASH 02/2026)

Contenu du document — Ce document compare le référentiel officiel du DEA (arrêté du 11 avril 2022, modifié le 4 juillet 2024) et le décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 avec les missions réellement exercées par les ambulanciers au CHU de Toulouse, dans les établissements psychiatriques autonomes (ex. Hôpital Marchant) et au sein des équipes SMUR.

Mise à jour du 27 juin 2026 — Intégration du périmètre SMUR — Cette version intègre les données du dossier AFASH (version 02/2026) sur les 12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP. Un nouveau tableau 2F et un tableau de synthèse global (Partie 3) ont été ajoutés.

Résultat clé — Sur 36 missions recensées, 28 sortent du périmètre DEA/décret 2022-629 (78 %). Le cœur de l'activité SMUR — assistance aux gestes de réanimation, damage control, gestion de scène, coordination en SSE — repose sur des compétences exercées sans aucune reconnaissance ni cadre de formation national.

Expéditeurs : CGT / SUD Santé Sociaux — CHU de Toulouse, Service Transport Patients — Julien TERRE · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel ambulancier)

PARTIE 1 — CE QUE PRÉVOIT LE RÉFÉRENTIEL OFFICIEL

DEA — Arrêté du 11 avril 2022, modifié le 4 juillet 2024

L'ambulancier est un professionnel de santé et du transport sanitaire. Au sein de la chaîne de soins, il assure la prise en soin et/ou le transport de patients à tout âge de la vie sur prescription médicale, ou dans le cadre de l'aide médicale urgente, au moyen de véhicules de transport sanitaire équipés et adaptés à la situation et à l'état de santé du patient.

Les 5 blocs de compétences du DEA — Volume horaire total : ~801 heures

Bloc	Intitulé	Volume horaire
Bloc 1	Prise en soin du patient à tout âge de la vie (accueil, soins d'hygiène, accompagnement, souffrance psychologique)	175 h
Bloc 2	Recueil de données cliniques et soins d'urgence (constantes, signes d'alerte, soins adaptés en urgence)	210 h
Bloc 3	Transport du patient (conduite, itinéraire, sécurité routière)	28 h
Bloc 4	Entretien des matériels et installations du véhicule	n.p.
Bloc 5	Travail en équipe et traitement des informations (traçabilité, dossier patient, transmissions)	n.p.

Actes professionnels élargis en AMU — Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022

Ce décret marque un tournant : de « simple conducteur-secouriste », l'ambulancier devient un professionnel de santé capable d'assister techniquement le médecin ou l'infirmier dans les actes d'aide médicale urgente.

Catégorie	Actes autorisés
À l'initiative de l'ambulancier (sous régulation médicale)	Prise de température, pulsations cardiaques, pression artérielle (non invasive) · Recueil de la glycémie par captation capillaire · Administration en aérosols de produits non médicamenteux · Évaluation de la douleur · Observation de l'état de conscience · Recueil du taux de SpO2 ou de CO (non invasif)
Sur prescription du médecin régulateur	Administration en aérosols/pulvérisation de produits médicamenteux (asthme, douleur) · Administration par voie orale ou intra-nasale (overdose d'opioïdes, douleur aiguë) · Administration par stylo auto-injecteur (choc anaphylactique, hypoglycémie) · Enregistrement et transmission d'un ECG à visée diagnostique
FAE SMUR (FPH)	175 heures (5 semaines) — Formation d'adaptation à l'emploi obligatoire pour tout

PARTIE 2 — CE QUE RÉALISENT RÉELLEMENT LES AMBULANCIERS

CHU de Toulouse · Établissements psychiatriques autonomes · SMUR

2A — Missions couvertes (partiellement) par le DEA socle — CHU de Toulouse

Mission	Bloc DEA	Remarque
Transport programmé sur prescription médicale (56 843 transports en 2025)	Bloc 3	Cœur de métier du référentiel
Recueil de constantes et surveillance clinique en cours de trajet	Bloc 2	Couvert
Soins de confort et d'hygiène de base lors du transport	Bloc 1	Couvert
Conduite du véhicule sanitaire	Bloc 3	Couvert
Traçabilité / dossier patient	Bloc 5	Couvert
Actes AMU (ECG, glycémie, O2, SpO2...)	Décret 2022-629	Couvert depuis 2022/2023
FAE SMUR — urgences préhospitalières (ambulanciers SMUR uniquement)	Formation complémentaire	175 h — obligatoire SMUR — non diplômante, hors RNCP

2B — Missions réalisées HORS référentiel DEA — CHU de Toulouse

Mission / Contexte	Volume / Données chiffrées	Lacune de formation identifiée
1. Transports psychiatriques sous contrainte (HSC, HDT)	3 751 transports en 2025	Pas de formation au cadre légal de la contrainte, ni à la désescalade verbale, ni aux protocoles d'alerte. Aucun des trois stages DEA obligatoires ne comporte de stage dédié en établissement psychiatrique. Risque renforcé par l'objectif national « zéro contention 2030 ».
2. Transports pénitentiaires (UHSI)	Conduite sous escorte Police Nationale	Aucun module sur la sécurité en milieu pénitentiaire, les protocoles IRIS ou la coordination avec l'administration pénitentiaire.
3. Patients fragiles et à risque infectieux élevé : Soins palliatifs · Médecine nucléaire · Médecine infectieuse / aplasie / greffés · Sorties de bloc / réanimation	Périmètre élargi — saisine ministérielle du 24 juin 2026	Soins palliatifs : accompagnement fin de vie, gestion de l'entourage · Médecine nucléaire : radioprotection, manipulation patients radioactifs · Infectieux/aplasie/greffés : isolement protecteur, asepsie renforcée · Sorties de bloc/réa : drains, sondes, perfusions, pousse-seringues — aucune formation dédiée.
4. Transports de produits sanguins labiles (PSL) — CHU de Caen Normandie	Constat intersyndicale 2026 ; transports de CGR, plaquettes, PFC effectués hors cadre DEA	Aucun bloc de compétences du DEA ne couvre les exigences de la chaîne du froid (arrêté du 10 septembre 2007), la traçabilité transfusionnelle obligatoire (feuille de suivi, concordances groupe/rhésus, bon de délivrance nominatif) ni la gestion des incidents de transport (rupture de chaîne du froid, défaillance du container isotherme). Responsabilité civile et pénale engagée sans couverture formatrice ni délégation formalisée — angle recevable par la DGOS et dans le cadre de la certification HAS.
5. Transports mortuaires nocturnes	Intervention souvent en solo	Cadre réglementaire spécifique, posture relationnelle face aux familles endeuillées. Aucun module dédié, aucune procédure définie.
6. Plans Blancs / médecine de catastrophe	Mobilisation pour pallier les déficits SAMU	Aucune équivalence avec la formation des équipes SAMU. Hors périmètre DEA.
7. Dépannage de premier niveau du matériel (outillé)	Intégrée dans la fiche de poste (proposition Direction)	Le Bloc 4 couvre l'entretien courant et le signalement des anomalies ; seuls les gestes de dépannage outillé restent hors référentiel.
8. Pédiatrie / néonatal : transports de couveuses avec SMUR pédiatrique	Transports néonataux et pédiatriques avec équipe SMUR pédiatrique (incubateurs de transport) — CHU et maternités de niveau III	Le DEA socle ne comporte aucune formation spécifique à la pédiatrie ni au néonatal. La FAE pédiatrique (2 jours) est facultative, non certifiante et hors RNCP. Or, le transport de nouveau-nés en incubateur requiert des compétences distinctes : (1) posologie pondérale : adaptation des doses selon le poids exact du nourrisson, en lien avec le médecin SMUR pédiatrique ; (2) voies aériennes réduites : assistance technique aux gestes sur des structures anatomiques plus petites (masques, sondes, canules pédiatriques), sans formation DEA dédiée ; (3)

		thermorégulation : surveillance et maintien actif de la température de l'incubateur, paramètre critique pour le nouveau-né prématuré. Aucun de ces trois aspects n'est couvert par le DEA ni par le décret 2022-629.
9. Psychologie infantile : gestion du stress de l'enfant et des parents lors d'un transfert pédiatrique vers un bloc opératoire	Transferts pédiatriques programmés vers bloc opératoire — enfants de 0 à 15 ans, avec les parents	Aucune formation DEA sur la gestion du stress de l'enfant et de ses parents lors d'un transfert vers un bloc opératoire. Le transfert vers le bloc est un moment d'anxiété majeure pour l'enfant (peur de l'inconnu, séparation, douleur anticipée) et pour les parents (culpabilité, impuissance). L'ambulancier assure seul le convoyage depuis le service pédiatrique jusqu'au sas du bloc, sans infirmier-e, et doit simultanément assurer la surveillance clinique de l'enfant et gérer l'accompagnement émotionnel du binôme enfant-parent. Le DEA socle ne comporte aucun module de psychologie infantile ni de communication adaptée à l'enfant selon l'âge (nourrisson, enfant en âge scolaire, adolescent). Cette lacune est particulièrement prégnante dans les services de pédiatrie chirurgicale, d'hématologie infantile et d'oncoPédiatrie du CHU.
10. Bariatrique : prises en soin de patients en surpoids ou lourdement appareillés	Patients obèses (IMC ≥ 40) ou porteurs d'appareillages lourds — activité récurrente au CHU (chirurgie bariatrique, réanimation, radiologie interventionnelle)	Le DEA ne comporte aucune formation à la prise en soin bariatrique. Or, la prévalence de l'obésité sévère (IMC ≥ 40) est en hausse constante et génère une activité de transport spécifique au CHU, notamment après chirurgie bariatrique (sleeve gastrectomie, bypass gastrique), en radiologie interventionnelle, en réanimation et en SSPI. Trois dimensions sont concernées : (1) équipement spécifique : brancards renforcés (capacité 250-300 kg), dispositifs de transfert (glisse-patient bariatrique, planche de transfert), sangles adaptées — aucun bloc DEA ne couvre le maniement de ces équipements ni les vérifications de charge avant transport ; (2) manutention adaptée et prévention des TMS : les techniques de manutention standard (Bloc 1) sont inadaptées et génèrent des troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les ambulanciers ; la formation aux gestes spécifiques bariatriques est absente du référentiel ; (3) surveillance clinique adaptée : mesure de la SpO ₂ , de la TA et de la fréquence respiratoire nécessite des brassards et capteurs adaptés à la morphologie bariatrique ; le risque de détresse respiratoire positionnelle (position demi-assise obligatoire en transport) est élevé et non abordé dans le DEA. Aucune formation, aucune procédure, aucune dotation en matériel spécifique ne sont prévues par le référentiel.

2C — Missions des ambulanciers en établissement psychiatrique autonome

Exemple : Hôpital Marchant, Toulouse. Les ambulanciers internes exercent un périmètre de missions au moins aussi étendu que ceux du CHU, et tout aussi absent du référentiel DEA. Les trois stages obligatoires du DEA (médecine d'urgence, transport sanitaire, structures de soins) ne comportent aucun stage dédié en établissement psychiatrique.

Mission / Contexte	Données	Lacune de formation
1. Consultations et hospitalisations somatiques de patients psychiatriques	Activité courante	Vigilance clinique et relationnelle renforcée (comorbidités somatiques, patient parfois opposant). Non couvert par le DEA socle.
2. Transports inter-services (centres de post-cure, CMP, hôpitaux de jour)	Réparti sur le département	Connaissance du parcours de soin requise, coordination étroite avec les équipes soignantes. Aucun module dédié.
3. Transferts vers UMD ou USIP	Trajets locaux et nationaux	Prise en charge de patients en phase de crise aiguë. Aucune formation à la gestion de la crise psychiatrique en transport.
4. Réintégrations après fugue ou sortie pathologique	Local et national	Risque d'agressivité et d'imprévisibilité comparable aux transports sous contrainte (cf. 2B-1). Aucune formation reconnue.
5. Transferts de détenus vers les services d'admission / UHSA	Escorte requise	Cumule contrainte psychiatrique ET contrainte pénitentiaire (escorte, sécurité). Hors périmètre DEA et UHSI classique.
6. Transports devant le JLD ou les tribunaux	Patients et détenus	Gestion administrative des demandes de transport et de la régulation associée. Aucun module dédié.

2D — Impact du Plan « Zéro contention 2030 » sur les transports psychiatriques

Le 2 juin 2026, la ministre Stéphanie Rist a fixé un objectif national de « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030, assorti d'un renforcement de la formation à la désescalade — mais ciblant les équipes d'hospitalisation, **pas les professionnels du transport sanitaire**.

— La réduction du recours à la contention mécanique en service se répercute mécaniquement sur le transport, où elle reste parfois mobilisée comme mesure de sécurité faute d'alternative.

— L'habitacle du véhicule, espace confiné et mobile, rend la gestion d'une crise comportementale structurellement plus risquée qu'en service.

— Aucun volet de formation dédié n'existe à ce jour pour les ambulanciers dans ce plan, alors que les missions les plus concernées (transports sous contrainte, UMD/USIP, réintégrations après fugue) sont précisément celles déjà identifiées hors référentiel DEA.

PARTIE 2 BIS — CE QUE RÉALISENT RÉELLEMENT LES AMBULANCIERS SMUR

D'après le dossier AFASH (Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers) — version 02/2026

□ NOUVEAU — Intégration périmètre SMUR (MAJ 27 juin 2026)

Cette partie s'appuie sur le dossier de demande de spécialisation d'ambulancier SMUR porté par l'AFASH (version 02/2026), qui documente l'écart entre le référentiel DEA socle (et le décret AMU n° 2022-629) et les compétences réellement mobilisées par l'ambulancier au sein du

Cette partie s'appuie sur le dossier de demande de spécialisation d'ambulancier SMUR porté par l'AFASH (version 02/2026), qui documente l'écart entre le référentiel DEA socle (et le décret AMU n° 2022-629) et les compétences réellement mobilisées par l'ambulancier au sein du **trinôme SMUR** (médecin – infirmier – ambulancier).

2E — Missions SMUR couvertes par le décret 2022-629 et le DEA

Mission / Activité SMUR	Bloc DEA / Décret	Remarque
Conduite du véhicule UMH (Unité Mobile Hospitalière)	Bloc 3	Couvert
Surveillance des constantes de base, monitoring simple (FC, TA non invasive)	Bloc 2	Couvert
Recueil de la glycémie capillaire (dextro)	Décret 2022-629	Couvert depuis 2022/2023
Recueil et transmission du SpO2	Décret 2022-629	Couvert depuis 2022/2023
Enregistrement et transmission d'un ECG à visée diagnostique	Décret 2022-629	Couvert depuis 2022/2023
Entretien courant, nettoyage et désinfection du véhicule et du matériel	Bloc 4	Couvert
Traçabilité, dossier de régulation / dossier d'intervention	Bloc 5	Couvert
Travail en équipe avec médecin et IDE/IADE (trinôme SMUR)	Bloc 5	Couvert dans son principe
FAE SMUR (175 h)	Formation complémentaire	Obligatoire pour affectation SMUR — non diplômante, hors RNCP

2F — Missions SMUR réalisées HORS champ de compétences DEA

Le dossier AFASH identifie **12 compétences spécifiques** mobilisées en pratique par l'ambulancier SMUR mais absentes du référentiel DEA socle et du décret 2022-629.

Mission / Contexte	Source AFASH 02/2026	Lacune de formation identifiée
1. Assistance technique aux gestes de réanimation (aide à l'intubation, pose de dispositifs, ventilation manuelle BAVU)	Compétence n°4 · Bloc 2 référentiel AFASH	Aucune formation reconnue au DEA à l'assistance aux voies aériennes ni aux gestes de réanimation, même sous supervision médicale.
2. Damage control préhospitalier : garrots, pansements compressifs, priorisation hémorragie-ventilation-état circulatoire	Module 3 « Damage Control » · Compétence n°4	Absent du DEA socle. Geste à enjeu vital, non sécurisé par un cadre de formation reconnu.
3. Préparation de perfusion pour l'IDE : kits, purge, sécurisation et	Champ d'action SMUR, dossier AFASH	Aucun module DEA sur la préparation des dispositifs de perfusion, même en simple appui logistique à

traçabilité		l'IDE.
4. Gestion de scène complexe ou instable (accident, violence, foule) et mesures NRBC de base	Compétence n°8 · Bloc 4 référentiel AFASH	DEA : aucune formation à l'évaluation des risques de scène ni aux mesures NRBC de base.
5. Intervention en SSE (plans ORSEC, plan blanc, plan rouge, tri/pré-tri sous supervision médicale)	Module 2 SSE · Bloc 4 référentiel AFASH	Hors périmètre DEA. Seule la FAE SMUR (non certifiante) aborde partiellement ce volet.
6. Coordination interservices en intervention (SDIS, forces de l'ordre, ARS, SAMU)	Compétences n°6 et n°8	Aucun module DEA dédié à la coordination opérationnelle interservices en situation d'urgence vitale.
7. Brancardage et évacuation complexes en milieux hostiles et hélicoptérés (HéliSMUR)	Compétence n°5	Le DEA couvre la manutention de base ; les techniques d'évacuation en milieu hostile ou hélicoptéré ne sont pas formalisées.
8. Maintenance et dépannage de premier niveau du matériel SMUR (UMH) selon procédures	Fiche de poste-type SMUR (ex. CHIC Alençon-Mamers)	Mentionné dans les fiches de poste sans dotation ni formation à l'outillage ou à la procédure.
9. Adaptabilité aux populations vulnérables en contexte SMUR (pédiatrie, psychiatrie/agitation, personnes âgées)	Compétence n°10	Recoupe les lacunes 2B/2C pour la psychiatrie ; non traité spécifiquement en contexte SMUR par le DEA.
10. Contribution structurée au débriefing post-intervention et analyse réflexive des pratiques	Compétence n°11 · Mois 5 référentiel AFASH	Démarche qualité/sécurité non intégrée comme compétence formelle du DEA.

Le dossier AFASH propose, sur cette base, la création d'une spécialisation post-DEA « Ambulancier SMUR » (5 mois, 600 à 700 heures), avec visée d'inscription au RNCP de niveau 4, accessible par formation continue ou VAE. Cette demande reste à ce stade une proposition portée par l'AFASH, non encore reconnue officiellement.

2G — Comparatif international de reconnaissance de la fonction ambulancier SMUR

Pays	Titre reconnu	Cadre réglementaire / Formation
Royaume-Uni	Paramedic	Reconnu par le HCPC (Health and Care Professions Council) — Formation universitaire 3 ans, niveau licence
Allemagne	Notfallsanitäter	Réforme 2014 (Notfallsanitättergesetz) — 3 ans de formation spécialisée — Niveau bac+
Québec	Technicien paramédic	ambulancier Diplôme reconnu nationalement — Formation collégiale 2 ans
États-Unis	Paramedic	Certifié NREMT (National Registry of EMTs) — Formation post-EMT — Certification nationale
France	Aucun titre RNCP spécifique pour l'ambulancier SMUR	FAE SMUR 175 h — non diplômante, hors RNCP · Proposition AFASH : spécialisation post-DEA 5 mois / 600-700 h / niveau 4 RNCP

PARTIE 3 — TABLEAU DE SYNTHÈSE COMPARATIF — TOUTES MISSIONS

CHU de Toulouse · Établissements psychiatriques * · SMUR † — 36 missions recensées

Ce tableau récapitule l'ensemble des missions identifiées et indique pour chacune si elle est couverte par le DEA 2022/2024 et/ou le décret n° 2022-629. Vert = couvert · Rouge = hors périmètre DEA.

Mission réalisée	Couvert par DEA/décret ?	Observation
Transport programmé sur prescription médicale	OUI	Cœur de métier du référentiel (Bloc 3)
Recueil de constantes et surveillance clinique en cours de trajet	OUI	Couvert (Bloc 2)
Soins de confort et d'hygiène de base lors du transport	OUI	Couvert (Bloc 1)
Conduite du véhicule sanitaire	OUI	Couvert (Bloc 3)
Traçabilité / dossier patient	OUI	Couvert (Bloc 5)
Actes AMU (ECG, glycémie, O2, SpO2...)	OUI	Couvert depuis 2022/2023 (décret 2022-629)
FAE SMUR (urgences préhospitalières)	OUI†	Dispositif distinct, 175 h — non diplômant, hors RNCP
Conduite du véhicule UMH et entretien courant matériel SMUR	OUI†	Couvert (Bloc 3 / Bloc 4)
Transports psychiatriques sous contrainte (HSC, HDT)	NON	Aucun stage dédié en établissement psychiatrique parmi les trois stages

		obligatoires
Transports pénitentiaires (UHSI)	NON	Aucun module sur la sécurité en milieu pénitentiaire, protocoles IRIS
Soins palliatifs — accompagnement fin de vie	NON	Simple allusion dans le référentiel
Médecine nucléaire (radioprotection)	NON	Absent du référentiel
Médecine infectieuse / aplasie médullaire / patients greffés	NON	Aucune formation à l'asepsie renforcée ni à l'isolement protecteur
Sorties de bloc opératoire / réanimation (dispositifs invasifs)	NON	Aucune formation aux drains, sondes, perfusions, PSE
Transports de produits sanguins labiles (PSL) — CHU Caen Normandie	NON	Aucun bloc DEA couvrant la chaîne du froid, la traçabilité transfusionnelle (arrêté 10/09/2007) ni la gestion des incidents de transport
Plans Blancs / médecine de catastrophe	NON	Hors périmètre DEA
Transports mortuaires nocturnes	NON	Aucun module dédié, aucune procédure définie
Dépannage matériel outillé de premier niveau	NON	Entretien courant couvert (Bloc 4) — dépannage outillé non couvert
Pédiatrie / néonatal — transports de couveuses avec SMUR pédiatrique (posologie pondérale, voies aériennes réduites, thermorégulation)	NON	FAE pédiatrique 2 jours facultative, non certifiante, hors RNCP. Aucun bloc DEA ne couvre la posologie pondérale, les voies aériennes réduites ni la thermorégulation en incubateur de transport.
Psychologie infantile — gestion du stress de l'enfant et des parents lors d'un transfert pédiatrique vers un bloc opératoire	NON	Aucune formation DEA sur la psychologie infantile ni la communication adaptée à l'enfant (nourrisson, scolaire, adolescent). L'ambulancier gère seul, sans IDE, le convoyage vers le bloc opératoire.
Bariatrique — prises en soin de patients en surpoids ou lourdement appareillés (équipement spécifique, manutention adaptée, surveillance clinique)	NON	Aucune formation DEA : pas de module sur les équipements renforcés (brancards 250-300 kg, glisse-patient bariatrique), sur la manutention spécifique (prévention TMS) ni sur la surveillance clinique adaptée (brassards/capteurs bariatriques, risque de détresse respiratoire positionnelle).
Consultations / hospitalisations somatiques de patients psychiatriques *	NON	Vigilance clinique et relationnelle renforcée requise — non couverte
Transports inter-services en établissement psychiatrique *	NON	Aucun module dédié
Transferts vers UMD / USIP *	NON	Aucune formation à la gestion de la crise psychiatrique en transport
Réintégrations après fugue / sortie pathologique *	NON	Risque comparable aux transports sous contrainte
Transferts de détenus vers l'UHSA *	NON	Cumule contrainte psychiatrique + contrainte pénitentiaire
Transports devant le JLD / tribunaux *	NON	Aucun module dédié
Assistance aux gestes de réanimation (intubation, BAVU) †	NON	Aucune formation DEA à l'assistance aux voies aériennes
Damage control / contrôle hémorragique avancé †	NON	Geste à enjeu vital non sécurisé par le DEA
Préparation de perfusion pour l'IDE †	NON	Aucun module DEA, même en appui logistique
Gestion de scène complexe / mesures NRBC †	NON	Aucune formation à l'évaluation des risques de scène
Intervention en SSE (ORSEC, plan blanc/rouge, tri/pré-tri) †	NON	Hors périmètre DEA, FAE SMUR aborde partiellement
Coordination interservices en intervention (SDIS, Police, ARS) †	NON	Aucun module DEA dédié
Brancardage / évacuation en milieux hostiles, HéliSMUR †	NON	Techniques avancées non formalisées au DEA
Maintenance / dépannage spécifique SMUR (UMH) †	NON	Mentionné en fiche de poste sans formation ni outillage
Débriefing structuré post-intervention SMUR †	NON	Démarche qualité non intégrée comme compétence DEA

* Missions identifiées pour les ambulanciers internes des établissements psychiatriques autonomes (ex. Hôpital Marchant, Toulouse) — cf.

CONCLUSION — BILAN QUANTITATIF ET PORTÉE ARGUMENTAIRE*28 missions sur 36 hors périmètre DEA — soit 78 % des missions recensées*

Catégorie	Nombre de missions	Proportion
Missions couvertes par le DEA / décret 2022-629	8	22 %
Missions HORS périmètre DEA (CHU + psychiatrie + SMUR + PSL)	28	78 %
TOTAL missions recensées	36	100 %

Sur l'ensemble des missions identifiées — CHU de Toulouse, établissements psychiatriques autonomes et SMUR confondus —, **28 missions sur 36 sortent du périmètre couvert par le DEA et le décret n° 2022-629**, contre 8 seulement qui y sont rattachées (soit les trois quarts des missions réalisées). L'ajout des transports de PSL (CHU Caen Normandie) confirme et étend ce déséquilibre.

Avant l'intégration du périmètre SMUR, ce constat portait sur les missions CHU et psychiatrie ; l'ajout des dix missions SMUR identifiées dans le dossier AFASH (2F) **confirme et aggrave** ce déséquilibre — le cœur même de l'activité SMUR (assistance aux gestes de réanimation, damage control, gestion de scène et coordination en SSE) reposant aujourd'hui sur des compétences exercées en pratique sans aucune reconnaissance ni cadre de formation national.

Cet écart constitue le fondement technique du dossier argumentaire pour le passage en catégorie B, et rejoint la demande portée par l'AFASH d'une spécialisation post-DEA « Ambulancier SMUR » reconnue au RNCP (5 mois / 600-700 h / niveau 4). Il est directement mobilisable dans la saisine adressée à la ministre Stéphanie Rist et au DGOS le 28 juin 2026, et dans le dossier technique à porter devant la DGOS à l'échéance 6-12 mois.

Références : Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au DEA (modifié le 4 juillet 2024) · Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels des ambulanciers · Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la FAE SMUR · Dossier AFASH, demande de spécialisation ambulancier SMUR, version 02/2026 · Données d'activité CHU de Toulouse — Service Transport Patients 2025 · Annonce Plan « Zéro contention 2030 », 2 juin 2026 (ministère de la Santé) · Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH · **Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles (transport des PSL)** · **Constat intersyndicale CHU de Caen Normandie, 2026.**

Signataires : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA (représentant du personnel ambulancier) · Jérôme JEAN-CHARLES (représentant du personnel ambulancier) — CHU de Toulouse, Service Transport Patients, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 — Document à usage syndical interne — Mise à jour : 27 juin 2026